

HIPOCALCEMIA

Alba González González, Ana Gutiérrez González, Jacinto Rodríguez Albo, Patricia Méndez Da Cuña.

Hipocalcemia	calcio total < 8,5 mg/dl o Ca iónico < 4,75 mg/dl.
--------------	--

Introducción

Se define la hipocalcemia como el valor de **calcio total < 8,5 mg/dl** o **calcio iónico < 4,75mg/dl**; el calcio total siempre se debe de corregir en función de la albúmina. El calcio (Ca) interviene en múltiples procesos fisiológicos, el calcio sérico (Cas) representa el 1% del calcio corporal total, se distribuye como: 47% Ca libre o calcio iónico (Cai) siendo la forma activa, 40% unido a proteínas (albumina) y 13% a aniones, estos porcentajes pueden variar según el PH y la concentración de aniones. El calcio sérico su valor normal varía entre 8,8 y 10,4mg/dl. Patología menos frecuente que la hipercalcemia.

Etiología:

- Hipoparatiroidismo: lesión glándulas paratiroides (postquirúrgico, postradiación).
- Déficit de vitamina D: hepatopatía, insuficiencia renal, malabsorción.
- Destrucción tisular: quemaduras, rabdomiolisis, pancreatitis, sepsis y lisis tumoral.
- Fármacos: diuréticos de asa, anticonvulsivantes, antiresortivos óseos, antihistamínicos H2...

Diagnóstico

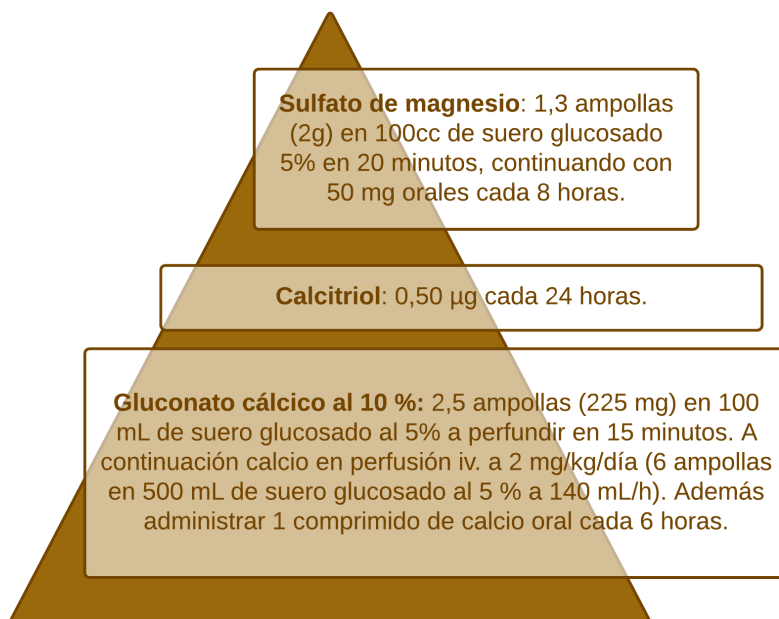
- **Clínica:**
 - Parestesias peribucales y en extremidades, calambres/espasmos musculares, tetania.
 - Disfagia, dolor abdominal, espasmo laríngeo y broncoespasmo.
 - Hipotensión, convulsiones, trastornos del ánimo.
- **Exploración: signos de Chovostek** (contractura de músculos maseteros al estimular el nervio facial) y de **Trousseau** (mucho más específico, contracción del carpo tras comprimir 3-5 minutos con el manguito de la presión por encima de la TA sistólica).
- **Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica:** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales, albumina, GOT, GPT, LDH, PCR. Dependiendo del laboratorio se podría solicitar Magnesio y Vitamina D. **Gasometría venosa, ECG, Rx tórax PA y Lateral.**

Tratamiento.

- **Inmediato:**

Si hipocalcemia sintomática leve: tratamiento oral de calcio (> 3-4 g/día).

Si hipocalcemia sintomática grave con síntomas de tetania, convulsiones, arritmias:



BIBLIOGRAFÍA

- F.B. Quero Espinosa et al. Hipercalcemia. En: L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez directores. Medicina de Urgencias y emergencias. 5ª ed. España: Elsevier; 2015. Capítulo 85, p. 510-512.
- Khosla S. Hipercalcemia e hipocalcemia. En: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. editores. Harrison. Principios de Medicina Interna, 19 ed. New York: McGraw-Hill; Capítulo 65.
- Fistera.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fistera.com; 2014 – [actualizada el 28 de diciembre de 2015; acceso 23 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.fistera.com>.